Correction de soins infirmiers en médecine

Examen blanc du diplôme d’État
INFAS Abengourou 2026 • IDE SFM 3
Version C • Durée du sujet 1 h 30

50 questions avec propositions, réponses, explications et sources. QCD : A = Vrai ; B = Faux. Pour les QCM, sélectionner le nombre de réponses indiqué.

Les références aux cours précisent les pages consultées. Les autres justifications sont rattachées à des sources institutionnelles ou professionnelles identifiées.

Questions à choix multiples

Cas clinique 1

Vous êtes de garde au service de médecine au CHR d’Abengourou en qualité d’infirmier diplômé d’État. Vous recevez Monsieur KODJO Paulin, cultivateur âgé de 47 ans. Il présente une raideur de la nuque, un trismus et une fièvre. Depuis son entrée à l’hôpital il y a deux jours, il n’a reçu aucun soin d’hygiène et de confort. Monsieur KODJO pèse 60 kg et mesure 1,58 m.

Question 1 — L'étudiant de licence 2 qui est de garde avec vous se référant au modèle conceptuel de Virginia Henderson a relevé les besoins ci- dessous. Indiquer les deux qui sont prioritaires ?

A. Être propre, soigné et protéger ses téguments et phanères

B. Se mouvoir et se maintenir en bonne posture

C. Éviter les dangers

D. S'occuper en vue de se réaliser

Réponse : A et C

Explication : Parmi les choix proposés, le défaut d’hygiène traduit le besoin d’être propre ; le tétanos impose de prévenir les dangers, notamment les spasmes et leurs complications. Le maintien de la respiration reste prioritaire si elle est menacée.

Source : INFAS, THEORIES ET CONCEPTS SOINS INFIRMIERS (2) (1).pdf, 2016–2017, p. 30–31, être propre et éviter les dangers ; OMS, Tétanos, symptômes et traitement.

Question 2 — Le diagnostic du médecin révèle que M. KODJO souffre de :

A. Paludisme grave

B. Tétanos

C. Méningite

D. Diphtérie

Réponse : B — Tétanos

Explication : Le trismus associé à la rigidité de la nuque oriente vers un tétanos. Son diagnostic est clinique. Une raideur de nuque isolée ne suffirait pas à trancher.

Source : OMS, Tétanos, rubrique Symptômes et diagnostic, who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/tetanus.

Question 3 — Quel est l'indice de masse corporelle de M. KODJO

A. 20

B. 24

C. 28

D. 30

Réponse : B — Environ 24 kg/m²

Explication : IMC = poids ÷ taille² = 60 ÷ 1,58² = 60 ÷ 2,4964 = 24,03 kg/m². Arrondi à l'unité : 24.

Source : Calcul à partir des données de l'étude de cas et de la formule indiquée dans l'explication.

Question 4 — Dans cet exercice de calcul, la dose totale de diazépam prescrite est de 0,5 mg/kg pour M. KODJO, qui pèse 60 kg. Les ampoules contiennent 10 mg dans 2 mL. Combien d'ampoules correspondent à cette dose ?

A. 1amp

B. 1,5amp

C. 2amp

D. 3amp

Réponse : D — 3 ampoules

Explication : Dose totale = 0,5 × 60 = 30 mg. Nombre d'ampoules = 30 ÷ 10 = 3, soit 6 mL de solution injectable. Ce calcul porte sur la dose totale donnée dans l'exercice.

Source : Calcul à partir des données de l'étude de cas et de la formule indiquée dans l'explication. Composition : ANSM, RCP VALIUM 10 mg/2 mL, § 2.

Question 5 — Quelle est la DCI du valium ?

A. Prazépam

B. Diazépam

C. Lorazépam

D. Bromazépam

Réponse : B — Diazépam

Explication : Valium est un nom de spécialité ; sa substance active est le diazépam, une benzodiazépine.

Source : ANSM, Résumé des caractéristiques du produit VALIUM 10 mg/2 mL, § 2, Base de données publique des médicaments.

Question 6 — Pour le calcul du débit, un volume final de 250 mL est prescrit sur 4 heures. La tubulure est calibrée à 20 gouttes/mL. Quel débit faut-il retenir, arrondi à la goutte la plus proche ?

A. 19gouttes/min

B. 20gouttes/min

C. 21gouttes/min

D. 22gouttes/min

Réponse : C — 21 gouttes/min

Explication : Débit = volume × calibration ÷ durée en minutes = 250 × 20 ÷ (4 × 60) = 20,83, soit 21 gouttes/min. En pompe : 250 ÷ 4 = 62,5 mL/h.

Source : Calcul à partir des données de l'étude de cas et de la formule indiquée dans l'explication.

Cas clinique 2

M. KOUAMÉ Oi Kouamé, 60 ans, planteur, consommateur chronique d'alcool et fumeur connu, souffre d'une tuberculose pulmonaire. Il est immunocompétent et se trouve sous votre responsabilité dans le service de médecine du CHR d'Abengourou. Son état d'hygiène est très dégradé.

Question 7 — Quels sont les trois facteurs reconnus favorisant la survenue d'une tuberculose maladie, de manière générale ?

A. Consommation nocive d'alcool

B. Infection à VIH avec immunodépression

C. IDR négative isolée

D. Obésité isolée

E. Sous-alimentation

Réponse : A, B et E

Explication : L'usage nocif d'alcool, l'immunodépression liée au VIH et la dénutrition augmentent le risque de tuberculose maladie. Le cas décrit un patient immunocompétent : on ne lui attribue donc pas un SIDA.

Source : OMS, Tuberculosis, rubriques facteurs de risque et symptômes, who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis.

Question 8 — Parmi les signes cliniques suivants de la tuberculose pulmonaire, cocher les deux qui sont des signes généraux.

A. Dyspnée

B. Amaigrissement

C. Toux

D. Expectoration

E. Asthénie

Réponse : B et E

Explication : L'amaigrissement et l'asthénie sont des signes généraux. La toux, l'expectoration et la dyspnée sont des symptômes respiratoires.

Source : OMS, Tuberculosis, rubriques facteurs de risque et symptômes, who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis.

Question 9 — Quelle intervention infirmière favorise l'observance du traitement antituberculeux ?

A. Expliquer le traitement, soutenir sa prise régulière et surveiller sa tolérance

B. Arrêter le traitement dès disparition de la toux

C. Imposer un jeûne prolongé sans prescription

D. Modifier seul les doses du traitement

Réponse : A

Explication : L'éducation et le soutien à l'observance aident le patient à poursuivre le traitement correctement. La surveillance permet de repérer les effets indésirables et d'alerter.

Source : OMS, WHO consolidated guidelines on tuberculosis, module 4, Tuberculosis care and support, recommandations 1.1 à 1.4, 2025.

Question 10 — Quelles sont les consignes à donner au malade avant qu'il ne débute son traitement antituberculeux ? Cocher les trois bonnes réponses.

A. Le traitement impose au moins six repas quotidiens

B. Le traitement doit être arrêté dès l'amélioration des symptômes

C. Convenir d'un accompagnement des prises adapté au patient, selon le protocole de soins

D. Respecter les doses et la durée prescrites

E. Signaler rapidement les effets indésirables et respecter les rendez-vous de suivi

Réponse : C, D et E

Explication : L'accompagnement des prises, le respect de la prescription et le suivi de la tolérance soutiennent l'efficacité du traitement. Les modalités sont adaptées au patient ; aucun nombre fixe de repas n'est imposé par principe.

Source : OMS, WHO consolidated guidelines on tuberculosis, module 4, Tuberculosis care and support, recommandations 1.1 à 1.4, 2025.

Question 11 — En vous référant au texte, quel est le besoin prioritaire de M. KOUAMÉ Oi Kouamé ?

A. Manger et boire

B. Éliminer

C. S'occuper en vue de se réaliser

D. Être propre soigner et protéger ces téguments

Réponse : D

Explication : Le texte indique explicitement un état d'hygiène très dégradé. Parmi les besoins proposés, celui d'être propre, soigné et de protéger ses téguments est donc directement documenté.

Source : INFAS, THEORIES ET CONCEPTS SOINS INFIRMIERS (2) (1).pdf, 2016–2017, p. 30, être propre, soigné et protéger ses téguments et phanères.

Questions générales

Question 12 — Dans quelle situation les soins palliatifs ont-ils une indication claire parmi les choix proposés ?

A. Amaigrissement isolé sans maladie identifiée

B. Vomissements en jet sans évaluation de leur cause

C. Maladie grave évolutive avec souffrance, notamment en phase terminale

D. Refus alimentaire isolé sans évaluation clinique

Réponse : C

Explication : Les soins palliatifs soulagent la souffrance liée à une maladie grave. Ils peuvent commencer précocement et ne sont pas réservés aux derniers jours de vie.

Source : OMS, Palliative care, définition et intégration précoce aux soins.

Question 13 — Parmi les éléments suivants deux sont des risques et complications de la pose de la sonde urinaire ; lesquels ?

A. Rétention d'urine comme indication initiale

B. Infection urinaire associée au sondage

C. Guérison immédiate d'une insuffisance rénale

D. Traumatisme avec perforation de l’urètre

E. Amélioration du confort après drainage d’une vessie distendue

Réponse : B et D

Explication : Le sondage peut entraîner une infection ou une lésion urétrale. Gonfler un ballonnet dans l’urètre est un geste incorrect pouvant provoquer une lésion.

Source : EAUN, Indwelling catheterisation in adults, 2024, chapitre 7, Catheter complications.

Question 14 — Le réservoir de germe de la fièvre typhoïde est : Cocher la bonne réponse

A. La chauve-souris

B. L'anophèle

C. Le singe

D. Le chien

E. L'homme

Réponse : E — L’être humain

Explication : Le réservoir de Salmonella Typhi est humain : malades et porteurs peuvent contaminer l’eau ou les aliments.

Source : CDC, Yellow Book, Typhoid and Paratyphoid Fever, rubrique Transmission.

Question 15 — Parmi les signes cliniques suivants trois sont compatibles avec un accès palustre de primo invasion non compliquée. Lesquels ?

A. Céphalées

B. Raideur méningée

C. Fièvre

D. Photophobie

E. Vomissement

Réponse : A, C et E

Explication : Céphalées, fièvre et vomissements sont compatibles avec le paludisme. Une raideur méningée doit faire rechercher une autre affection ou une complication, plutôt que conclure à un accès simple.

Source : CDC, Symptoms of Malaria, rubrique Symptoms, cdc.gov/malaria/symptoms/index.html.

Question 16 — Quelles sont les deux comorbidités qui augmentent le risque de forme grave de COVID-19 parmi ces choix ?

A. Furoncle isolé

B. Dermatose bénigne isolée

C. Diabète sucré

D. Maladie cardiovasculaire, notamment cardiopathie hypertensive

Réponse : C et D

Explication : Le diabète et les maladies cardiovasculaires font partie des affections associées à un risque accru de forme grave.

Source : OMS, Coronavirus disease COVID-19, 27 novembre 2025, rubrique personnes à risque.

Question 17 — Quelle voie de transmission du VIH correspond à une contamination lors d'un rapport sexuel non protégé ?

A. Transmission par le sang et dérivés ;

B. Transmission sexuelle ;

C. Transmission materno-fœtale (mère-enfant)

Réponse : B — Transmission sexuelle

Explication : Le VIH peut se transmettre lors d'un rapport sexuel par exposition à des liquides biologiques infectants. Les voies sanguine et mère-enfant sont d'autres modes de transmission.

Source : OMS, HIV and AIDS, rubriques transmission et prévention.

Question 18 — Quels sont les trois facteurs de risque reconnus de maladies chroniques non transmissibles parmi les choix suivants ?

A. Surpoids ou obésité

B. Profession de cultivateur en elle-même

C. Tabagisme

D. Sédentarité

E. Repos régulier suffisant

F. Alimentation végétale équilibrée

Réponse : A, C et D

Explication : Le surpoids, le tabagisme et l'inactivité physique augmentent le risque de plusieurs maladies non transmissibles. Une prise de poids isolée n'équivaut pas nécessairement à un surpoids.

Source : OMS, Noncommunicable diseases, rubriques facteurs comportementaux et métaboliques, 25 septembre 2025.

Question 19 — Parmi la liste des maladies suivantes, deux sont virales, lesquelles ?

A. Fièvre typhoïde

B. Rougeole

C. Grippe

D. Diphtérie

E. Choléra

Réponse : B et C

Explication : La rougeole est due au virus de la rougeole et la grippe aux virus influenza. Les trois autres affections proposées sont bactériennes.

Source : OMS, Measles et Influenza seasonal, rubriques définition et causes.

Question 20 — En cas d'OAP avec dyspnée, chez un patient conscient dont l'état hémodynamique le permet, quelle installation est indiquée ?

A. Décubitus latéral, jambes repliées

B. Décubitus dorsal à plat

C. Position assise ou demi-assise, jambes pendantes selon la tolérance

Réponse : C

Explication : Le cours recommande la position demi-assise, jambes pendantes, pour faciliter la respiration et limiter le retour veineux. L'installation est adaptée à la tolérance et à la pression artérielle.

Source : INFAS, Médecine L2 .pdf, p. 8–9, OAP, accueil et installation.

Question 21 — Chez une personne consciente présentant une dyspnée cardio-respiratoire et supportant cette position, quelle installation facilite généralement la respiration ?

A. Installation Dorsale

B. Installation Latérale

C. Installation Assise

Réponse : C — Installation assise

Explication : La position assise ou demi-assise facilite généralement la ventilation. Elle ne doit pas être imposée à un patient en collapsus ou ne la tolérant pas.

Source : INFAS, Médecine L2 .pdf, p. 8–9, prise en charge de l'OAP.

Question 22 — Choisissez deux signes d'insuffisance ventriculaire droite dans cette liste

A. Oligurie

B. Œdèmes des membres inférieurs

C. Dyspepsie

D. Vomissements

Réponse : A et B

Explication : Le cours mentionne l'oligurie et les œdèmes des membres inférieurs parmi les signes possibles de l'insuffisance cardiaque droite. Les œdèmes cardiaques sont souvent bilatéraux et prennent le godet.

Source : INFAS, Médecine L2 .pdf, p. 25–26, insuffisance cardiaque droite.

Question 23 — Choisissez deux objectifs des soins palliatifs parmi les propositions suivantes :

A. Soulager la souffrance des proches liée à la maladie

B. Garantir la guérison de toute maladie grave

C. Soulager la douleur et les autres symptômes du malade

D. Remplacer systématiquement tout traitement de la maladie par des soins de confort

Réponse : A et C

Explication : Les soins palliatifs visent le confort et la qualité de vie du patient et de ses proches. Ils peuvent être associés aux traitements dirigés contre la maladie.

Source : OMS, Palliative care, définition et intégration précoce aux soins.

Question 24 — Quel examen utilise une méthode immunochromatographique pour détecter des antigènes de Plasmodium falciparum dans le sang ?

A. NFS

B. Goutte épaisse

C. TDR du paludisme adapté à P. falciparum

D. Frottis sanguin

Réponse : C

Explication : Le TDR usuel détecte des antigènes parasitaires, par exemple HRP2 ou pLDH selon le test. La goutte épaisse et le frottis recherchent les parasites par microscopie.

Source : OMS, Global Malaria Programme, Rapid diagnostic tests et How malaria RDTs work.

Questions à choix doubles

Question 25 — La fièvre jaune est une zoonose.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le cycle sylvatique fait intervenir des primates non humains et des moustiques pouvant transmettre le virus à l'humain. Un cycle urbain humain–moustique–humain existe aussi.

Source : OMS, Yellow fever, rubrique Transmission.

Question 26 — La vomique peut se manifester par le rejet brutal et abondant de pus ou de liquide par la bouche, lors d'un effort de toux.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Elle traduit l'évacuation dans une bronche d'une collection thoracique ou de voisinage. Elle peut être massive ou fractionnée.

Source : Académie nationale de médecine, Dictionnaire médical, entrée vomique, academie-medecine.fr/le-dictionnaire/index.php?q=vomique.

Question 27 — L'odynophagie correspond à une douleur ressentie lors de la déglutition.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L'odynophagie désigne une douleur lors de la déglutition. La dysphagie désigne une difficulté à avaler.

Source : Institut national du cancer, Glossaire, odynophagie, cancer.fr/glossaire/odynophagie.

Question 28 — La cholécystite aiguë est le plus souvent liée à l'obstruction du canal cystique par un calcul.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L'obstruction du canal cystique par un calcul favorise la distension et l'inflammation de la vésicule. Il existe également des cholécystites sans calcul.

Source : INFAS, Médecine L2 .pdf, p. 78–80, lithiase biliaire et complications. Complément : Assurance Maladie, Comprendre la cholécystite aiguë, 16 septembre 2025, ameli.fr/assure/sante/themes/cholecystite/comprendre-cholecystite-aigue.

Question 29 — Après une endoscopie sous sédation, une somnolence excessive, une hypotension ou une dépression respiratoire doivent être recherchées.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La surveillance après sédation porte sur la conscience, la ventilation, l'oxygénation et la circulation, jusqu'à une récupération satisfaisante.

Source : British Society of Gastroenterology, Guidelines on sedation in gastrointestinal endoscopy, Gut, 2024, recommandations 10 et surveillance en récupération, doi:10.1136/gutjnl-2023-330396.

Question 30 — Chez les jeunes, une pression des pairs qui encourage les rapports sexuels non protégés peut favoriser l'exposition au VIH.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le risque est lié au comportement d'exposition favorisé par cette pression, et non au simple fait d'appartenir à un groupe. La prévention inclut l'éducation et les moyens de protection.

Source : OMS, HIV and AIDS, rubriques transmission et prévention, rubrique facteurs de risque et prévention ; interprétation du comportement décrit.

Question 31 — La transmission de la maladie à COVID-19 se fait toujours par voie direct.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le virus se transmet surtout par des particules respiratoires dans l'air ; une transmission par des surfaces contaminées est aussi possible. Reformulation : la transmission n'est pas exclusivement directe.

Source : OMS, Coronavirus disease COVID-19, 27 novembre 2025, rubrique Overview.

Question 32 — L'incubation de l'infection à COVID-19 dure en moyenne 15 jours.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Quinze jours n'est pas la durée moyenne. Reformulation : les symptômes apparaissent habituellement quelques jours après l'exposition, souvent dans un délai de trois à six jours selon les variants.

Source : OMS, Coronavirus disease COVID-19, 27 novembre 2025, rubrique symptômes et incubation.

Question 33 — La dysosmie et la dysgueusie constituent des signes pathognomoniques de la maladie à COVID-19.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Les troubles de l'odorat et du goût sont évocateurs mais peuvent avoir d'autres causes. Reformulation : dysosmie et dysgueusie sont des symptômes possibles, non pathognomoniques de COVID-19.

Source : OMS, Coronavirus disease COVID-19, 27 novembre 2025, rubrique symptômes.

Question 34 — La stigmatisation, lorsqu'elle retarde le recours au dépistage et aux soins, ainsi que le non-respect des mesures limitant les contacts pendant la période contagieuse peuvent favoriser la diffusion de la COVID-19.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La dissimulation des symptômes et les contacts pendant la contagiosité peuvent entretenir la transmission. L'accompagnement doit faciliter l'accès aux soins et l'application des mesures de prévention.

Source : OMS, Social stigma associated with COVID-19, 24 février 2020 ; OMS, Coronavirus disease COVID-19, 27 novembre 2025, prévention.

Question 35 — Le dépistage volontaire d'une femme enceinte, même en l'absence de son conjoint, suivi d'une prise en charge adaptée, contribue à prévenir la transmission du VIH à l'enfant.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le test et l'accès aux soins de la femme ne doivent pas dépendre de la présence du conjoint. Le dépistage du partenaire est proposé, avec son propre consentement.

Source : OMS, Consolidated guidelines on HIV testing services, 2019, § 6.2.6, couples et partenaires, p. 154 ; directives VIH, 2021, femmes enceintes.

Question 36 — La diastole ventriculaire est la phase de relaxation au cours de laquelle les ventricules se remplissent de sang provenant des oreillettes.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Après la relaxation initiale et l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires, les ventricules se remplissent. La diastole n'est pas une inactivité de tout le cœur.

Source : National Heart Lung and Blood Institute, How the Heart Works, How the Heart Beats, rubriques Electrical activity et Blood pressure, nhlbi.nih.gov/health/heart/heart-beats.

Question 37 — Chez certaines personnes vivant avec le VIH et présentant une insuffisance rénale chronique, ABC + 3TC + DTG peut être envisagé après évaluation spécialisée, avec adaptation de la lamivudine si nécessaire.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Cette association peut éviter le ténofovir disoproxil, mais elle n'est pas automatiquement adaptée à tout patient. Le choix dépend notamment de la fonction rénale et des conditions d'emploi de l'abacavir ; les associations fixes peuvent limiter l'adaptation des doses.

Source : NIH ClinicalInfo, Adult and Adolescent ARV Guidelines, Appendix B, doses en insuffisance rénale, entrées ABC, 3TC et ABC/3TC/DTG.

Question 38 — Le glomérule est un réseau de capillaires qui assure la filtration du plasma à l'origine de l'urine primitive.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La filtration laisse passer l'eau et de petites molécules ; les cellules sanguines et la plupart des protéines sont normalement retenues.

Source : NIDDK, Your Kidneys & How They Work, rubrique The glomerulus filters your blood.

Question 39 — Des nausées et des vomissements peuvent révéler une insuffisance rénale chronique avancée.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le cours décrit des manifestations digestives, notamment anorexie, nausées et vomissements. Elles sont non spécifiques ; l'IRC peut longtemps rester peu symptomatique.

Source : INFAS, Médecine L2 .pdf, p. 115–116, IRC, manifestations cliniques.

Question 40 — En raison de la gravité de la co-infection, tout malade dépisté tuberculeux de nos jours doit faire obligatoirement l'objet d'un counseling en vue du test de dépistage VIH, même sans son consentement.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le dépistage VIH doit être proposé aux patients tuberculeux avec information et consentement. Reformulation : un refus du test doit être respecté ; la co-infection ne justifie pas un dépistage imposé.

Source : OMS Afrique, HIV/AIDS, rubrique HIV testing : caractère volontaire et droit de refus.

Question 41 — Le lavage des mains à l'eau et au savon est la mesure principale qui empêche la transmission aérienne de la tuberculose en milieu de soins.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L'hygiène des mains reste une précaution générale, mais ne maîtrise pas à elle seule les aérosols tuberculeux. Reformulation : la prévention repose notamment sur le repérage rapide, le traitement, la ventilation et la protection respiratoire adaptée.

Source : CDC, Tuberculosis Infection Control, rubriques précautions aériennes et mesures environnementales, cdc.gov/tb-healthcare-settings/hcp/infection-control/index.html.

Question 42 — La pollakiurie est l'augmentation du volume des urines pendant la nuit.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La pollakiurie est une augmentation de la fréquence des mictions, souvent peu abondantes. Reformulation : elle ne correspond pas à une augmentation du volume urinaire nocturne.

Source : Assurance Maladie, Pollakiurie ou envie fréquente d'uriner, définition, ameli.fr/assure/sante/themes/pollakiurie-envie-frequente-uriner/definition-symptomes-causes.

Question 43 — L'insuffisance cardiaque se définit par l'état de défaillance circulatoire qui résulte de l'impossibilité pour le cœur d'assurer un débit sanguin suffisant au besoin de l'organisme.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Cette définition exprime l’incapacité du cœur à fournir un débit adapté aux besoins de l’organisme. L’insuffisance cardiaque peut aussi se manifester par des pressions de remplissage élevées.

Source : INFAS, Médecine L2 .pdf, p. 24–27, insuffisances cardiaques.

Question 44 — Il n'y a pas d'ulcère gastro-duodénal sans la bactérie Helicobacter pylori.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Helicobacter pylori est une cause majeure, mais des ulcères peuvent survenir sans cette infection, notamment sous AINS. Reformulation : l’ulcère gastroduodénal n’est pas toujours lié à H. pylori.

Source : INFAS, Médecine L2 .pdf, p. 70, ulcères gastroduodénaux, facteurs favorisants.

Question 45 — Le signe de Koplik, observé dans la rougeole, correspond à de petits points blanchâtres sur la muqueuse de la face interne des joues.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Il s’agit d’un énanthème de la muqueuse buccale, et non d’une éruption sur la peau externe de la joue.

Source : CDC, Clinical Overview of Measles, rubrique Clinical features ; CDC, surveillance manual, chapitre Measles, Koplik spots.

Question 46 — L'anophèle femelle est l'agent pathogène du paludisme.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le parasite du genre Plasmodium est l’agent pathogène. Reformulation : l’anophèle femelle infectée est le vecteur du paludisme.

Source : OMS, Malaria, rubriques Overview et Transmission.

Question 47 — La cirrhose est une pathologie de la rate en réponse à des agressions de natures variées, caractérisées par un bouleversement de l'architecture splénique.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La cirrhose concerne le foie. Reformulation : elle correspond à une désorganisation de l’architecture hépatique associant notamment fibrose et nodules de régénération.

Source : INFAS, Médecine L2 .pdf, p. 46–47, cirrhoses, définition et anatomopathologie.

Question 48 — La rougeole est une maladie immunisante.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La guérison de la rougeole confère généralement une immunité durable contre la maladie. Cette propriété ne justifie pas de rechercher une infection naturelle, qui expose à des complications.

Source : CDC, Pink Book, chapitre 13 Measles, rubrique Immunity.

Question 49 — La transmission de la maladie à COVID-19 se fait toujours par voie direct.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le virus se transmet surtout par des particules respiratoires dans l'air ; une transmission par des surfaces contaminées est aussi possible. Reformulation : la transmission n'est pas exclusivement directe.

Source : OMS, Coronavirus disease COVID-19, 27 novembre 2025, rubrique Overview.

Question 50 — Le diagnostic biologique de certitude de la fièvre typhoïde est basé uniquement sur l'hémoculture et/ou la coproculture.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L'hémoculture est l'examen de référence usuel et la coproculture peut contribuer au diagnostic. Le mot « uniquement » est inexact : une culture médullaire peut aussi identifier la bactérie. Reformulation : la confirmation repose sur la mise en évidence de Salmonella Typhi dans un prélèvement approprié.

Source : CDC, Clinical Guidance for Typhoid Fever and Paratyphoid Fever, rubrique Diagnosis, cdc.gov/typhoid-fever/hcp/clinical-guidance/index.html.

Liens des principales références complémentaires

OMS, soins palliatifs
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care

OMS, tuberculose
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis

OMS, soins et accompagnement de la tuberculose
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK613102/

OMS, COVID-19
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/coronavirus-disease-(covid-19)

OMS, VIH et SIDA
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

OMS, dépistage VIH volontaire
https://afro.who.int/health-topics/hivaids

OMS, recommandations VIH 2019
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/336323/9789241550581-eng.pdf

NIH, ARV et insuffisance rénale
https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/hiv-clinical-guidelines-adult-and-adolescent-arv/drug-characteristics-tables-renal-hepatic-insufficiency-full

OMS, TDR du paludisme
https://www.who.int/teams/global-malaria-programme/case-management/diagnosis/rapid-diagnostic-tests

ANSM, RCP Valium
https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/medicament/67959261/extrait

BSG, sédation en endoscopie
https://doi.org/10.1136/gutjnl-2023-330396

EAUN, sondage urinaire
https://nurses.uroweb.org/guidelines/indwelling-catheterisation-in-adults-urethral-and-suprapubic